

TERZA ETÀ
ATTIVA PRO ·
BONUS 2

+60 ESERCIZI *RECUPERO* POST-CADUTA

Bonus 2 di 4 · Terza Età Attiva Pro · edizione 2026



TERZA ETÀ ATTIVA PRO · Bonus 2 · 2026

INDICE · BONUS 2



1

Fase 1 · In Letto

..... pp. 4-13

2

Fase 2 · In Piedi con Appoggio

..... pp. 14-23

3

Fase 3 · Passi con Deambulatore

..... pp. 24-32

4

Fase 4 · Autonomia Progressiva

..... pp. 33-38





Dalla stanza al passo autonomo

*Il bonus per la riabilitazione
post-caduta in 4 fasi progressive.*



Una caduta nell'anziano è un evento sistemico: fisico, psicologico, sociale.



Riabilitare senza forzare le tappe è la sfida più delicata del fisioterapista geriatrico.



Questo bonus è il tuo protocollo:
60 esercizi organizzati in 4 fasi cliniche progressive, con criteri obbligatori di avanzamento tra le fasi.



Non saltare mai una fase —
le complicanze tardive esistono.



Respirazione Terapeutica Post-Caduta

*Ricondizionamento respiratorio
fase 1 • 8 cicli • supino*



OBIETTIVO:

Rimettere in moto
il respiro dopo trauma



MATERIALI:

Cuscino testa



WARNING:

Se dispnea acuta
segnalare medico



ESECUZIONE

- 1) Supino con cuscino sotto testa
- 2) Respirazione diaframmatica 8 cicli 4-6
- 3) 2 volte al giorno
- 4) Se paziente ha algia costale,
respiro corto e frequente





Circolazione Caviglia Post-Caduta



Prevenzione TVP fase 1 · 3×20 · supino



OBIETTIVO:

Prevenire trombosi
durante
immobilizzazione



MATERIALI:

Nessuno



WARNING:

Se dolore polpaccio
segnalare immediato

1 ESECUZIONE

1. Vedi scheda circolazione caviglia letto Bonus 1.
Frequenza per post-caduta: 3 volte al giorno minimo.

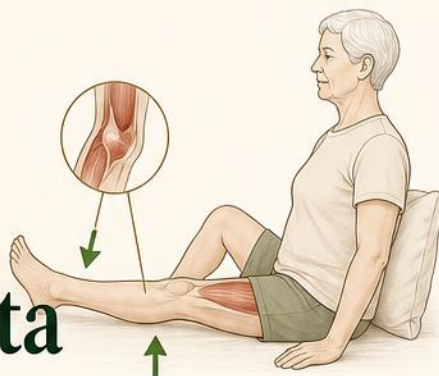


TERZA ETÀ
ATTIVA PRO



Attivazione Quadricipite Isometrica Post-Caduta

Prevenire atrofia quadricipite fase 1 · 3×10 per gamba

**OBIETTIVO:**

Prevenire atrofia
da immobilizzazione

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

Se dolore al ginocchio
consultare

**ESECUZIONE**

1



1) Supino gamba estesa

2



2) Contrarre quadricipite
(spingere ginocchio
contro letto) 5 sec

3



3) Rilasciare

4

10×

4) 10× per gamba

5



5) 3 serie/giorno



Stringere Glutei Post-Caduta

Prevenire atrofia glutei fase 1 · 3×10

**OBIETTIVO:**

Prevenzione piaghe
da decubito + trofismo

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

Fermare al primo
segno di dolore
o instabilità



ESECUZIONE

1

1) Supino

2

2) Stringere glutei 5 sec

3

3) Rilasciare

4

4) 10×

5

3 serie/giorno





Mobilità Braccia a Letto Post-Caduta

Prevenire rigidità arti superiori fase 1 • 2×10



OBIETTIVO:

Prevenire rigidità
spalla-gomito



MATERIALI:

Nessuno



WARNING:

Se dolore spalla per trauma
da caduta, consultare
medico pri

ESECUZIONE

- 1 Supino
- 2 Braccia lungo il corpo
- 3 Alzare un braccio disteso portandolo dietro la testa
- 4 Riportare
- 5 10× per braccio
- 6 2 serie



Supino



Braccia lungo il corpo



Alzare un braccio disteso
portandolo dietro la testa



Riportare



10× per braccio

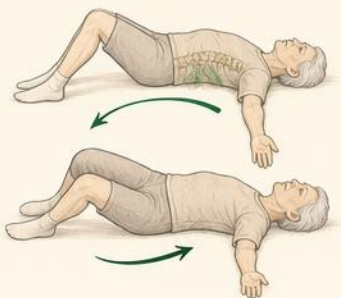


2 serie



Rotazione Tronco a Letto Post-Caduta

Mobilizzazione tronco fase 1 · 2×5 per lato



OBIETTIVO:
Prevenire rigidità
dorso-lombare



MATERIALI:
Cuscino



WARNING:
Fermare al primo
segno di dolore o
instabilità

ESECUZIONE

1) 1) Supino ginocchia flesse



2) 2) Lasciare cadere ginocchia unite verso destra fino a sfiorare letto



3) 3) 5 sec



4) 4) Sinistra



5) 5) 5× per lato

6) 2 serie



**TERZA ETÀ
ATTIVA PRO**

Passaggio a Seduta con Aiuto Letto

Prima transizione fase 1 · assistito · 2×5



OBIETTIVO:

Recuperare passaggio supino-seduto in sicurezza



MATERIALI:

Cintura ergonomica · caregiver



WARNING:

Se vertigini all'alzarsi (ipotensione ortostatica), fermare

ESECUZIONE

- 1 Supino ginocchia flesse.
- 2 Ruotare tronco+bacino insieme verso lato letto.
- 3 Portare gambe fuori dal letto lasciandole scendere.
- 4 Spingere con braccio sano per portarsi seduto.
- 5 Fermare 30 sec seduto verificando equilibrio.
- 6 5 volte/giorno con supervisione.



1 Supino ginocchia flesse.



2 Ruotare tronco+bacino insieme verso lato letto.



3 Portare gambe fuori dal letto lasciandole scendere.



4 Spingere con braccio sano per portarsi seduto.



5 Fermare 30 sec seduto verificando equilibrio.



6 5 volte/giorno con supervisione.



Criteri di Avanzamento Fase 1 → Fase 2

— Quando passare a fase in piedi · check-list —



OBIETTIVO:

Sicurezza nel passaggio di fase



MATERIALI:

Osservazione clinica



PROCEDURA

1. 5 criteri OBBLIGATORI:

2. 1) Assenza dolore acuto in movimento >3 giorni
3. 2) Passaggio supino-seduto autonomo in <2 min
4. 3) Tolleranza posizione seduta >20 min senza vertigini
5. 4) Pressione arteriosa stabile ai passaggi posturali
6. 5) Motivazione ad alzarsi

Se anche **1 solo** criterio non è soddisfatto,
restare fase 1 e rivalutare.



ATTENZIONE:

Il fisioterapista decide, non il paziente o famiglia —
la fretta è nemica



Gestire la Paura di Cadere di Nuovo

Componente psicologica della caduta · continuo



OBIETTIVO:

Riconoscere e trattare la paura come parte del percorso



MATERIALI:

Colloquio + validazione + esposizione graduale



Regole:

- 1 **VALIDARE la paura**
(“è normale, ha senso”)
- 2 **NON minimizzare**
(“non ti succederà più”)
- 3 **NON pushare oltre il livello di comfort attuale**
- 4 **ESPOSIZIONE GRADUALE:**
prima esercizio in letto, poi seduto sicuro, poi in piedi con appoggio, poi passi con deambulatore, poi passi con appoggio unilaterale
- 5 **Successo piccolo + celebrazione**
(“bravissima, sei rimasta in piedi 30 secondi”)
- 6 **Se paura $\geq 7/10$ dopo 1 mese,**
riferire a psicologo.



WARNING: *La paura si vince col successo, non con la logica*



Segnali di Complicanze Post-Caduta Tardive

Riconoscere complicanze che emergono giorni dopo · monitoraggio



Da monitorare per 2 settimane post-caduta:

- 1) **Ematoma cranico tardivo** (cefalea peggiora nei giorni, sonnolenza, vomito, confusione) → **118**
- 2) **Trombosi venosa** (dolore polpaccio, gonfiore, calore, arrossamento) → **medico**
- 3) **Frattura misconosciuta** (dolore che non passa, difetto funzionale) → **RX**
- 4) **Piaghe da decubito** (arrossamento persistente zone d'appoggio) → **medico**
- 5) **Depressione reattiva** (chiusura, rifiuto attività, insonnia) → **psicologo**
- 6) **Riduzione autonomia irreversibile** (freezing motorio) → **équipe geriatria**

REGOLA D'ORO:

Chiedere sempre 'come sta ora?' con controlli a 48h, 1 settimana, 2 settimane post-caduta

Il Primo In Piedi Post-Caduta

Momento critico fase 2 · 15 min · supervisionato



OBIETTIVO:

Prima verticalizzazione in totale sicurezza



MATERIALI:

Deambulatore o 2 operatori · misuratore pressione

PROCEDURA:

- 1 Seduto sul bordo del letto piedi appoggiati.
- 2 Misurare pressione da seduto.
- 3 Chiedere se vertigini.
- 4 Con aiuto di deambulatore o 2 operatori, alzarsi lentamente.
- 5 Restare in piedi 30 sec con supervisione.
- 6 Sedersi.
- 7 Misurare pressione in piedi (attenzione a ipotensione ortostatica).



⚠ ATTENZIONE:

Fermare se: vertigini severe, PA sistolica scende >30 mmHg, senso di svenimento, pallore, sudore freddo.



Stazione Eretta con Appoggio

Fase 2

Tolleranza posizione eretta · 3×30 sec



OBIETTIVO:

Recuperare tolleranza alla posizione eretta



MATERIALI:

Deambulatore o spalliera stabile



WARNING:

Sempre supervisione — no da soli fase 2

ESECUZIONE

- 1 In piedi con mani su deambulatore/spalliera
- 2 Piedi paralleli larghezza spalle
- 3 Mantenere posizione 30 sec
- 4 Sedere e riposare 1 min
- 5 3 ripetizioni
- 6 Progressione graduale: 30 sec → 1 min → 2 min → 5 min



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Trasferimento Peso da un Piede all'Altro

Rieducazione trasferimenti carico · 2×10



OBIETTIVO:

Rieducazione carico su ogni arto



MATERIALI:

Deambulatore per appoggio bilaterale



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità



ESECUZIONE

- 1 In piedi con mani su deambulatore.
- 2 Spostare lentamente peso su gamba destra sollevando leggermente sinistra (2-3 cm).
- 3 Tenere 3 sec.
- 4 Cambio.
- 5 10× per lato.
- 6 2 serie.



**TERZA ETÀ
ATTIVA PRO**

Semi-Squat con Deambulatore Fase 2

Rinforzo quadricipiti in piedi • 2×5



OBIETTIVO:

Rinforzo funzionale gambe



MATERIALI:

Deambulatore stabile



WARNING:

Ridurre profondità squat se dolore ginocchio

ESECUZIONE

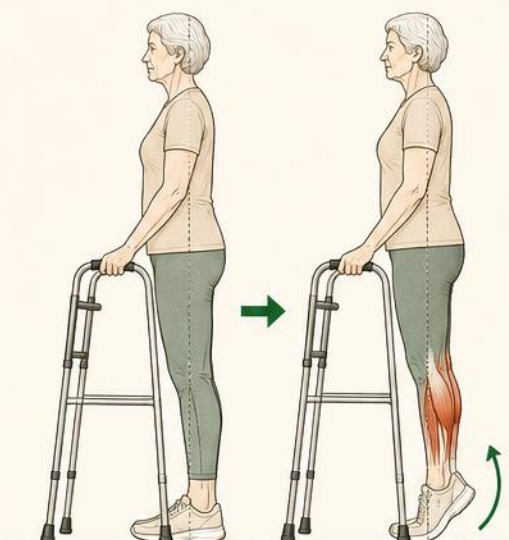
- 1 In piedi con mani su deambulatore.
- 2 Piegare ginocchia scendendo di 10-15 cm come per sedersi.
- 3 Risalire lentamente.
- 4 5×.
- 5 2 serie.
- 6 Sicuro perché con appoggio bilaterale.



TERZA ETÀ ATTIVA
PRO

Sollevamenti Punte con Deambulatore

Rinforzo polpacci fase 2 • 2×8



OBIETTIVO:

Rinforzo polpacci
con sicurezza
deambulatore



MATERIALI:

Deambulatore



WARNING:

Fermare al primo
segno di dolore
o instabilità

ESECUZIONE

- 1) In piedi mani su deambulatore
- 2) Sollevare lentamente entrambi talloni
- 3) Tenere 2 sec
- 4) Abbassare lentamente
- 5) 8×
- 6) 2 serie



TERZA ETÀ
ATTIVA

PRO

Marcia sul Posto con Deambulatore

Rinforzo funzionale della marcia · 2×30 sec

**OBIETTIVO:**

Rieducare gesto della marcia in sicurezza

**MATERIALI:**

Deambulatore

**WARNING:**

Fermare al primo segno di dolore o instabilità



ESECUZIONE

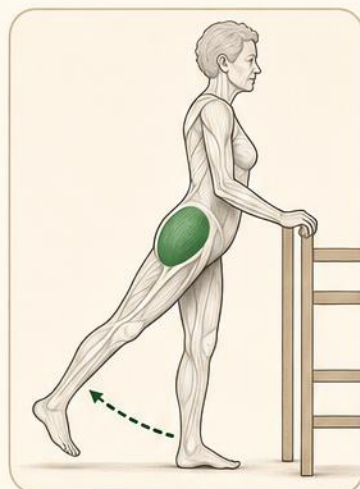
- 1 In piedi con deambulatore
- 2 Marcia sul posto lenta 30 sec
- 3 Riposo 1 min
- 4 Ripetere
- 5 Progressione: aumentare durata e velocità gradualmente.



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Estensione Anca con Appoggio

Rinforzo glutei fase 2 · 2×8 per gamba



OBIETTIVO:

Rinforzo gluteo
massimo per
stabilità pelvica



MATERIALI:

Spalliera o
deambulatore



WARNING:

No inclinazione
lombare

ESECUZIONE

- 1) In piedi con mani su appoggio
- 2) Estendere una gamba indietro tenendola dritta 15-20 cm
- 3) Tenere 2 sec
- 4) Tornare
- 5) 8× per gamba
- 6) 2 serie





Abduzione Anca in Piedi con Appoggio

Rinforzo medio gluteo · 2×8 per gamba

**OBIETTIVO:**

Rinforzo medio gluteo
per stabilità laterale

**MATERIALI:**

Spalliera o
deambulatore

**WARNING:**

Fermare al primo segno
di dolore o instabilità



ESECUZIONE

- 1 In piedi con mano su appoggio.
- 2 Aprire lateralmente una gamba dritta di 15-20 cm.
- 3 Tenere 2 sec.
- 4 Tornare.
- 5 8× per gamba.
- 6 2 serie.



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Criteri Avanzamento Fase 2 → Fase 3

Quando passare ai primi passi



OBIETTIVO:

Sicurezza avanzamento fase



MATERIALI:

Test clinici

PROCEDURA:

1

5 criteri OBBLIGATORI:

1. Stazione eretta con appoggio bilaterale >2 min senza fatica;
2. Trasferimento peso senza vertigini;
3. 10 sit-to-stand consecutivi in <90 sec;
4. Pressione arteriosa stabile in piedi;
5. Motivazione a camminare.

2

Se anche 1 non è soddisfatto, restare fase 2 e rivalutare a 5 giorni.

3

Valutare sempre la tolleranza allo sforzo e la sicurezza del paziente.

4

Coinvolgere il team riabilitativo per conferma congiunta.

5

Documentare i risultati nel diario clinico.

6

Ripetere la valutazione se cambiano le condizioni cliniche.

7

Procedere a Fase 3 solo dopo conferma dei criteri.



⚠ ATTENZIONE:

Non lasciarsi mettere fretta dal paziente ansioso di camminare — la sicurezza prima

Segnali di Instabilità in Fase 2

Riconoscere quando fermare l'esercizio in piedi



Segnali STOP immediato:

- ① Vertigini o giramenti testa
- ② Pallore o sudore freddo
- ③ Dispnea acuta
- ④ Dolore toracico
- ⑤ Tremori marcati arti inferiori
- ⑥ Distorsione dello sguardo
- ⑦ Confusione



Sedere immediatamente,
misurare pressione, chiamare
medico se persiste >10 min.



REGOLA D'ORO:
Fermare al primo segno
di dolore o instabilità



I Primi Passi con Deambulatore Post-Caduta

Rieducazione al passo · 20 min · supervisionato



OBIETTIVO:

Primo passo con deambulatore



MATERIALI:

Deambulatore · scarpe antiscivolo · corridoio libero



PROCEDURA:

- 1 Deambulatore davanti al paziente
- 2 Paziente in piedi con mani sul deambulatore
- 3 Avanzare deambulatore 20-30 cm
- 4 Passo con gamba destra
- 5 Portare gamba sinistra a destra (o passi alternati)
- 6 5 metri
- 7 Pausa



ATTENZIONE:

Sempre supervisione — no da soli fase 3



Cammino in Avanti con Deambulatore

Rinforzo pattern deambulatorio • 3×10 m



OBIETTIVO:

Consolidare pattern cammino



MATERIALI:

Deambulatore • corridoio



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità.

ESECUZIONE

1

Cammino in avanti con deambulatore per 10 metri.

2

Ritorno.

3

3 ripetizioni.

4

Riposo 2 min tra ripetizioni.



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Cammino Indietro con Deambulatore

Rieducazione cammino retrogrado · 2×5 m

**OBIETTIVO:**

Rieducazione
reverse gait

**MATERIALI:**

Deambulatore ·
corridoio

**WARNING:**

Solo con supervisione:
rischio caduta

ESECUZIONE

- 1 In piedi con deambulatore
- 2 Passo indietro corto lento con gamba destra
- 3 Portare sinistra
- 4 Avanzare deambulatore indietro
- 5 5 metri
- 6 2 ripetizioni



TERZA ETÀ
ATTIVA
PRO

Cammino Laterale con Deambulatore

Rieducazione stabilità laterale · 2×5 m per lato



OBIETTIVO:

Rieducazione
carico laterale



MATERIALI:

Deambulatore ·
corridoio



WARNING:

Fermare al primo segno
di dolore o instabilità

1 ESECUZIONE

- 1 In piedi laterale al deambulatore (una mano);
- 2 Passo laterale con gamba lontana;
- 3 Avvicinare gamba vicina;
- 4 Avanzare deambulatore laterale;
- 5 5 metri;
- 6 Cambio lato.



Cammino con Doppio Compito

Riabilitazione funzioni esecutive del cammino · 3×10 m



OBIETTIVO:

Rieducazione cammino in condizioni reali (con distrazioni co



MATERIALI:

Deambulatore · corridoio



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità



ESECUZIONE

1

Cammino con deambulatore 10 metri contemporaneamente contando all'indietro da 20.

2

Ritorno.

3

3 ripetizioni con temi diversi (contare, nominare frutti, spellare parole).

4

Se il paziente si ferma quando parla, indicatore di funzioni esecutive ridotte.



TERZA ETÀ ATTIVA
— PRO —



Cambio di Direzione con Deambulatore

Rieducazione rotazione • $3 \times 360^\circ$ per verso



OBIETTIVO:

Rieducazione cambio direzione (attività ad alto rischio cadu)



MATERIALI:

Deambulatore • spazio 2×2 m



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità.



ESECUZIONE

1

In piedi con deambulatore.

2

Girare lentamente in cerchio 360° in senso orario a piccoli passi.

3

Fermarsi.

4

Antiorario 360° .

5

3 ripetizioni per verso.



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Salire e Scendere Gradino con Corrimano

Rieducazione scale • 2×5



OBIETTIVO:

Rieducazione
salita/discesa gradini



MATERIALI:

Gradino singolo •
corrimano su entrambi
i lati



WARNING:

Regola mnemonica:
“in alto il buono,
in basso il cattivo”

ESECUZIONE

- 1 In piedi davanti al gradino.
- 2 Mano su corrimano.
- 3 **SALITA:** gamba forte prima.
- 4 **DISCESA:** gamba debole prima.
- 5 5 salite.
- 6 Riposo.



TERZA ETÀ ATTIVA
— PRO —



Criteri Avanzamento Fase 3 → Fase 4



Quando passare a autonomia progressiva



OBIETTIVO:

Sicurezza avanzamento
all'autonomia



MATERIALI:

Test clinici



PROCEDURA:

1 5 criteri OBBLIGATORI:

- 1 50 metri con deambulatore
senza pause
- 2 TUG <20 sec
- 3 Tinetti >20
- 4 Cambio direzione fluente
- 5 Motivazione all'autonomia

2 Se anche 1 non è soddisfatto,
restare fase 3.



ATTENZIONE:

Non tutti i pazienti passano a fase 4 —
alcuni restano stabilmente in fase 3
(con deambulatore) e va bene.





Scegliere l'Ausilio Corretto per la Deambulazione

Deambulatore vs bastone vs stampelle

**OBIETTIVO:**

Corretta scelta dell'ausilio in base alle capacità

**MATERIALI:**

Valutazione clinica

**GERONTOLOGICO
4 RUOTE
(rollator)**

- Pazienti con equilibrio moderato
- Bisogno di riposo (ha sedile)

**DEAMBULATORE
ARTICOLATO**

- Pazienti fragili
- Controlla velocità

**DEAMBULATORE
FISSO**

- Massima stabilità
- Pazienti molto fragili

**BASTONE**

- Pazienti con lieve instabilità lato singolo

**STAMPELLE ANTIBRACCIO**

- Pazienti giovani post-frattura

**Regola:**

*iniziare con più supporto
e ridurre progressivamente.*

**WARNING:** Fermare al primo segno di dolore o instabilità

I Primi Passi senza Ausilio

Rieducazione autonomia · 15 min · supervisionato



OBIETTIVO:

Primo cammino autonomo
dopo recupero



MATERIALI:

Corridoio con corrimano
su entrambi i lati

PROCEDURA:

- 1 In piedi corridoio
(con corrimano di sicurezza
vicino).
- 2 Deambulatore lasciato dietro.
- 3 Passi lenti nel corridoio
senza deambulatore.
- 4 3-5 metri.
- 5 Se instabilità, appoggio
al corrimano.
- 6 Sedere.
- 7 Ripetere gradualmente
aumentando distanza.



ATTENZIONE:

Sempre supervisione fino a 100 metri
autonomi consecutivi

Equilibrio Mono-Podalico

Fase 4

Rinforzo equilibrio avanzato · 3×15 sec per gamba



OBIETTIVO:

Recuperare equilibrio mono-podalico (protettivo cadute)



MATERIALI:

Spalliera per sicurezza



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità.



ESECUZIONE

- 1 In piedi vicino a spalliera.
- 2 Mano leggera su appoggio.
- 3 Sollevare un piede 5-10 cm.
- 4 Mantenere 15 sec.
- 5 Cambio.
- 6 3× per gamba.



TERZA ETÀ ATTIVA

PRO



Cammino di Uscita nel Corridoio Sicuro

*Rieducazione cammino distanza ·
3×50 metri*



OBIETTIVO:

Aumentare
resistenza al
cammino



MATERIALI:

Corridoio lungo
con corrimano



WARNING:

Fermare al primo
segno di dolore o
instabilità



ESECUZIONE

1 50 metri senza pause.

2 Riposo 3 min.

3 3 serie.

4 Registrare velocità e distanza
(progressione settimanale).



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Scale Complete con Corrimano

*Rieducazione scale intera rampa •
2 salite + 2 discese*



OBIETTIVO:

Rieducazione
scale complete



MATERIALI:

Rampa di scale +
corrimano



WARNING:

Fermare al primo segno
di dolore o instabilità



ESECUZIONE

1

Salire una rampa intera
(8-12 gradini) con mano
su corrimano

2

Fermarsi in cima

3

Riposo 1 min

4

Scendere

5

2 salite + 2 discese
totali



TERZA ETÀ ATTIVA
PRO

Dimissione dalla Fase 4 · Consegna al Paziente

Chiusura percorso post-caduta · 45 min



OBIETTIVO:
Pass paziente
all'autogestione



MATERIALI:
Kit di dimissione



PROCEDURA

1. Consegnare:
 - 1) Rivalutazione finale scritta (Tinetti + Berg + TUG + Borg);
 - 2) Programma 8 esercizi 'salvavita' quotidiani (15 min/giorno);
 - 3) Segnali di allarme per ricontatto immediato;
 - 4) Contatto medico curante di riferimento;
 - 5) Data del follow-up (3 mesi);
 - 6) Kit di sicurezza casa (checklist 20 punti);
6. Kit di sicurezza casa (checklist 20 punti);
7. Certificazione partecipazione.



ATTENZIONE:

Non prolungare artificialmente se il paziente ha raggiunto gli obiettivi.

Prevenire una Nuova Caduta • Checklist Casa

Home safety post-recupero • una tantum



OBIETTIVO:

Prevenire recidive
con audit casa



MATERIALI:

Casa del paziente



20 punti da controllare:

- | | | | | | |
|----|---|--|----|---|--|
| 1 |  | Illuminazione notturna
corridoio e bagno | 11 |  | Braccialetto SOS |
| 2 |  | Tappeti rimossi o fissati | 12 |  | Scarpe chiuse con suola
antiscivolo |
| 3 |  | Corrimano sulle scale | 13 |  | Occhiali aggiornati |
| 4 |  | Sbarre di appoggio in bagno
(WC + doccia) | 14 |  | Farmaci in scatola settimanale |
| 5 |  | Tappeto antiscivolo doccia | 15 |  | Rimuovere cavi a terra |
| 6 |  | Sedia doccia se serve | 16 |  | Sedie stabili con braccioli |
| 7 |  | Rialzo WC se serve | 17 |  | Materiale utile ad altezza vita |
| 8 |  | Interruttori accessibili | 18 |  | Piano di. |
| 9 |  | Telefono raggiungibile
ogni stanza | | | |
| 10 |  | Cellulare sempre carico | | | |



WARNING: Audit casa fondamentale —
il 70% delle recidive avviene per ambiente non modificato





Glossario Recupero Post-Caduta

CONOSCERE • PREVENIRE • TORNARE A MUOVERSI



Fase acuta:
primi 3-7 giorni
post-caduta.



Freezing motorio:
blocco del cammino.



Fase subacuta:
giorni 8-30
post-caduta.



Deambulatore rollator:
con 4 ruote e sedile.



Fase cronica:
dopo 30 giorni.



Test TUG:
Timed Up and Go
per screening cadute.



**Ematoma sottodurale
tardivo:**
complicanza cranica tardiva.



Scala Tinetti:
0-28 equilibrio e andatura.



Rieducazione al passo:
recupero pattern
deambulatorio.



Scala Berg:
0-56 equilibrio funzionale.





GRAZIE

Hai finito il Bonus 2.

Ora la sfida è la continuità:
prevenire una seconda caduta è più
difficile che riabilitare la prima.

Consegna al paziente il kit di dimissione —
questo è il vero successo del percorso.

PROSSIMI PASSI

- 1 Consegna checklist Sicurezza Casa
- 2 Programma follow-up a 3 mesi
- 3 Rivaluta con Tinetti + Berg + TUG del Bonus 3



TERZA ETÀ ATTIVA PRO
Bonus 2 • 2026